

DOI:10.13288/j.11-2166/r.2023.24.002

基于系统中医元整体原理探讨气的内涵

胡孙林, 刘雷蕾, 孙一珂, 祝广钦, 孙霄, 何雪, 颜纯佳, 马淑然✉

北京中医药大学, 北京市朝阳区北三环东路11号, 100029

[摘要] 在系统梳理从物质、能量、信息、关系实在角度对气的认识的基础上, 引入系统中医的元整体观念, 同时结合“三层物质理论”这一气的最新研究成果, 试完善气理论体系的结构框架, 展现一元之气的发生发展规律。强调元整体发生观中的气化等级秩序, 并据此来指导临床认识“气病”, 帮助医者把握疾病的基本病机, 即气运失常, 助其树立以调气为要、对患者进行系统中医调治的意识。同时将人置于时空结构中探讨, 指出治病疗疾要遵从天、地、人“三和”的原则。

[关键词] 气; 系统中医学; 元整体; 三层物质理论

由于历史的局限性和各研究的切入角度不同, 虽然目前学术界对于“气”的内涵已进行多领域、多维度的研究, 提出了“气是物质”“气是能量”“气是信息”“气是关系实在”等观点, 但对于气本质内涵的认识仍尚待深入, 亟待结合现代系统科学的研究成果进行理论完善与深化。系统中医学是在系统科学指导下对生命的运动规律、健康维护以及疾病防治规律等方面的问题进行探讨^[1], 是以系统科学为主导的中医现代研究^[2]。元整体原理是系统中医理论体系中的七大原理之一, 其揭示和总结了人这一整体的本原特性, 强调了人是分化系统而非组合系统^[3]。此外, “气本体论”思想^[4]对于中医理论和临床处方用药、针灸推拿等亦具有重要的现实意义。本文拟从系统中医元整体原理的角度对气的内涵进行探讨, 以为中医学从元整体角度理解天人关系、认识人之疾病的本质提供新的思路, 并为在临床上运用系统中医相关理论对疾病的调治提供指导。

1 关于“气”的中医学认识

1.1 气是物质

对于气的物质性认识, 在《黄帝内经》中已有详实的记载, 其中“人以天地之气生”概括了气是

构成人的物质基础这一基本观点^[5]。《素问·六节藏象论篇》曰:“天食人以五气, 地食人以五味。五气入鼻, 藏于心肺, 上使五色修明, 音声能彰”, 明确指出气是维持人生命活动的重要物质基础。从气血津液并提的角度来看, 血、津、液都是物质性极强的物质实体, 因此, 与血、津、液等概念平行理解时, 气也可看作为以物质性为主导性能的存在; 从临床角度来看, 吴又可认为“杂气”是客观存在的物质, 可采用药物“制服”, 无疑是对气之物质性在临床治疗上的发微^[6]。结合现代科学技术, 有研究认为生命起源于原始大气的化合物, 原始大气和正负电荷可视为中医学中的精微物质, 人之气等同于细胞膜周边的带电离子^[7]; 认为“脏腑之气”的现代医学本质主要涉及不断运动、相互作用、共同完成分子水平做功或能量转化的特殊蛋白质、三磷酸腺苷及其他生物小分子^[8]。综上所述, 气的物质性认识在不断推进并逐步深化。

1.2 气是能量

太虚和气的关系一直是张载哲学思想中辩论的焦点, 太虚不等于气, 二者是“不一不二”的关系, 其中太虚是绝对的本体^[9], 而气则是勾连本体发生变化的能量流。在张载哲学思想中, 始终强调“气化论”而非“气本论”, 实质上就是在试图阐述气是推动元整体发展的能量。在指导中医临床实践中, “气主动”“气主煦之”等思想均是由气是能量这一观点衍化而来, 在此思想的指导下, 针对具有

基金项目: 北京中医药大学系统中医调治与中医健康管理方案合作研究(BUCM-2022-JS-ZX-005)

✉ 通讯作者: mashuran64@sina.com

疲乏无力、懒动少言等气虚征象的患者，中医运用补气药来治疗，其蕴含的道理与气是能量且气具有补充机体能量的认识相契合。此外，现代科学研究亦证实气具有高度的能量属性，有研究指出，在现代科技水平下用电磁场表征中医学中的气是相对科学的^[10]；在梳理 1995–2015 年“气学”理论研究成果的基础上，提出气为不具固定形态，并通过渗透、聚散、出入等形式贯穿于一切事物之间的生物电磁场^[11]。综上可见，气的能量属性一直备受关注，对其内涵的理解也在不断深入。

1.3 气是信息

甲骨文中，气的字形（𠂇）与“三”相似^[12]，上下各一横分别代表天地，在天地之间再加一横代表从无到有而产生的气流，因此“气”的造字本义是在天地之间飘逸并沟通天地的气流，这与《庄子·知北游》中“故万物一也……通下一气耳”的论述相契合。“通下一气”在一定程度上可以理解为气是天人沟通、万物交流的中介，在这种认识的指导下，气的本质是信息流。《灵枢·顺气一日分为四时》言：“春生、夏长、秋收、冬藏，是气之常也，人亦应之”，在气的沟通下，人与天地同频，人随四时同律。此外，现代研究也试图从分子层面解释气是信息这一客观事实，如有研究者提出气的推动、生化、沟通作用，包括神经元的传导以及钙离子、钠离子、酶类、肽类等物质进行的信息交流^[13]。

1.4 气是关系实在

“通下一气”中“一气”并不局限于阐明万物的本质都是气，其深层含义应在于此贯穿万物之气乃是一个连续的整体。对于气的理解，应关注气作用的过程，即气的升降出入以及由此产生的运动变化。气具有关系实在的先在属性，这一属性不仅使元气得以演化，并且在生发过程中一直存在，因此，从“关系实在”的角度理解气的作用过程有助于全局把握气的综合作用。在生发过程中，因为气化作用使得连贯的整体分化出了不同的属性，产生了功能的差异，进而表现出宇宙中的万事万物^[14]。从中医学视角来看，疾病多是“气病”，而“气病”的本质是“关系病”；由于气化作用失调，从而引起多脏腑、多基础物质的关系失常，进而导致异常表象的产生，这便是“病”。此外，许多器质性病变的产生往往会经历一个“关系病”的前期阶段^[15]，关系的严重失常、气化的深层失序，导致

功能性疾病产生器质性的病理改变，因此，大部分“实体实在”异常的机理背后是“关系实在”的失常。

2 中医系统论元整体原理阐释

系统中医学是在系统科学主导下的中医学研究，其特点是把人作为开放复杂巨系统，从复杂巨系统的特性和规律来研究人的生命运动规律，并服务于临床。系统中医学中有关基本理论的内容称为中医系统论，元整体原理是中医系统论的基本原理之一。元整体原理指出混沌未分的原始整体分化出各部分，且整体产生和决定部分。临床上，元整体原理要求医生将局部病变放到整体的背景中看待^[16]。

2.1 整体分化产生部分

元整体原理的核心在于绝对性和独立性，这里的“绝对”和“独立”并不是指元整体的封闭和局限，而是强调整体的本原地位。整体内的各部分均是由整体分化而产生的，与整体紧密相连、不可分割，这种发生的关系呈现出元整体自身的超越性和逻辑先在性。

2.2 整体不等于部分之和

古代元气论是元整体观的思想基础，“道生一，一生二，二生三，三生万物”（《道德经》）简明扼要地概括了元整体观对万事万物发生发展的根本看法。元整体这一分化系统与合整体这一组合系统的区别在于：元整体具有系统质，而合整体只具有要素质。系统质只存在于要素质的相互作用中，其以要素所组成的结构为载体，是系统功能、行为、属性的体现；要素质无法归纳出系统质，一旦整体被分解，只能遵循组合机制重新组合成整体并重新产生出系统质^[17]。简言之，元整体的发展是“一（整体）分化为多（要素质与系统质）”的过程，而合整体的形成则是“多（要素质）组合为一（整体）”的过程。在临床对疾病的认识中，疾病的本质包括要素质和系统质。因此，治疗疾病时，不仅要关注要素质的正常与否，更应从元整体的角度注重系统质的调节^[18]。

2.3 局部与整体之间存在等级秩序

元整体观将万物的发生发展看作“一变多”的过程，强调由整体分化而成的部分之间具有联系性^[19]，但是这种联系不是平行联系，而是具有等级秩序。理论上，在常态下后生的从属于原生的，分化的受控于本一的，在上下层次之间有着系统质与要素质的差别。中医辨证突破了解剖的脏腑局限，治疗顽疾时，看似作用于在表之形、气，实则

是利用形、气对元气的影响,多靶点协同,恢复元气功能,进而使得元气能够整体调节系统状态。其本质仍在于利用从动关系恢复功能,治疗系统质病,符合自然生化发展的基本规律和趋势。

3 气的本质特点在于元整体性

气表现的多样性与丰富性启示“一气”发生了演化,而气演化产生的万事万物在层次、性质、功能方面具有差异但却又密切相关。从系统科学元整体的角度来看,气的本质特点在于元整体性。

3.1 气分化产生万物

气化可理解为“气的分化”。《论衡·自然》以“天地合气”“万物自生”的思想贯穿始终,气和则万物自生,气化则万物自成。《庄子·知北游》中“故万物一也……通下一气耳”的论述是气分化产生万物的理论圭臬,其鲜明地指出人的生命物质是由宇宙一元之气同源变生而来,世间万物皆由原始的湛一之气衍化而生,气是从“一无所有”到“所有一切”的根本。映射到自然科学的语境中,受精卵的生长发育无不是气化过程推动的结果,生物体的新陈代谢无不是气化过程有力的体现^[20]。综上,从多角度可知气化过程即是气的分化进程,而“分化”一词本身就蕴含着“万物源一”的思想,与元整体强调“本一性”和“一化多”的观点相合,初步阐明了气的本质特点在于元整体性。

3.2 元气分化而成形-气-神

元气为气之元,是人生命之根。形-气-神是相互关联的一个整体,形-气-神相互作用、相互协调保持人生命的有序平衡状态,维持机体正常的生命活动^[21]。正如《元气论》中所言:“人之生也,禀天地之元气为神为形,受元一之气为液为精”,元气与形-气-神的关系是主动与从动的关系,形-气-神是由一元之气分化发展而来的同一层级的系统质和要素质之集成体现,四者共同调控人的生命活动。元气对于维持人之生理状态、修复人之病理状态具有重要的临床指导意义。正如《景岳全书·传忠录·虚实篇》所言:“元气完固,则精神昌盛”,调元气,是从本而调,发挥元气的主动性,能使形-气-神从动地发生变化,进一步说明了气的本质特点在于元整体性。

3.3 气的分化具有等级秩序

三层物质理论^[22]为深刻理解气的本质提供了启发。该假说依据质、能、信息的不同隐显状态将宇宙物质分为三个层面:第一层面物质是实体,能

量和信息隐藏其中;第二层面物质是以能量为显性的无形非实体客观存在;第三层面物质是以信息为显性的时空结构混合信息体。其在一定程度上揭示了“气学说”的本质,可用于阐述人与自然的发生和存在规律。

元整体视域下,气的分化具有等级秩序,下级只可影响上级而不可逆转为上级。基于元整体视域,可从三个方面对三层物质理论进行完善:1)对于每一层面而言,分化过程中同一层级的质量、能量、信息可以相互影响。2)对于元整体发生系统而言,元气的气化过程就是元整体的发生过程。气化过程之所以发生,在于气关系实在的本原属性,静则阴聚,动则阳生,活动度小的部分逐渐趋向于表现出气的物质属性,而活动度大的部分则趋向于表现出气的能量属性,阴阳互作,能量推动物质的变化,物质变化体现能量的流动,在变化之中信息就此显现。在分化的过程流中,形成秩序大致如下:元气→分化之阴气和分化之阳气→实体气和非实体气。3)人属于元整体系统的一种,元气是人的“生成元”^[23],为人生命活动调控的核心,为本,其所分化之形-气-神为标。分化之阴气继续聚集而成实体性结构或体内的其他物质成分(实体气);分化之阳气继续演化,不仅在实体结构形成的过程中密切联系,且在实体结构形成后仍不消失,而是继续行使其特定功能,并成为各实体结构沟通的中介(非实体气)。从临床实践来看,先功能失常和先结构失常者均有,所以实体气和非实体气在征象上具有互相平行的关系。生理状态下,元气守藏,而以形-气-神为用;病理状态下,形-气-神失守(单纯气-神失常,常表现为功能性病变而无指标的异常,而形失常则表现为器质性病变或呈现指标的异常)为病浅,其预后良,若元气受扰,则形-气-神俱失,其预后恶;临床诊断上,人之非实体气作用于实体气异常,可传递出物质结构异常的信息(易于检测),实体气作用于非实体气异常,可传递出系统功能失常(能量流动障碍)的信息。

综上,气的分化存在明显的等级秩序,气的分化过程深刻体现了其具有元整体性这一本质特点。

4 理解气的元整体性具有重要的临床指导意义

中医治病以治本为要。张介宾《景岳全书·杂证谟·诸气》认为“夫百病皆生于气”,明确指出了气的紊乱是多种疾病的关键病机。因此,深刻认

识气的本质特点、把握气的元整体分化秩序对于医者临床分析病机、选用疗法、整体调理便显得十分重要。

4.1 指导分析疾病的整体病机

《类经·情志九气》云：“气之在人，和则为正气，不和则为邪气。凡表里虚实，逆顺缓急，无不因气而至，故曰百病皆生于气。”中医系统论视角下的疾病，多为“气病”和“关系病”，中医学所认识的气郁、气滞、气逆、气闭等气的病理状态，轻则影响人的情绪，导致情绪低落、意志消沉等，进一步则会导致痰饮、瘀血等病理产物的形成，最终出现实质性的器官病变。可见，气是人这一系统内推动和维持正常生理活动的重要保障，一旦气的运转失序或者气的功能降低，该等级下的秩序就会紊乱，乱则生害，疾病丛生。因此，中医治病以调气为要，其本质上就是恢复气的运行状态，与元整体等级分化下的秩序保持步调一致。对于具体疾病而言，如临床上肺胀的患者，实则应理气化痰而祛邪，虚则应补气扶虚以培正；急则应调形恢复刻下的稳定，缓则应调气修复失序之本^[24]。

4.2 指导治疗疾病的调气核心

《黄帝内经》更多提到的是形-神一体观，但据前文所述元整体的发生规律，一元之气的变化产生了形-气-神，此外神对生命的主宰需要借助于中介即气的调控。因此，在同一层级中，应关注气的中介作用，通过调气而调形、神；在发生秩序上，通过调下游之气而理上游之元气。具体而言，如治疗情志病时要用理气药开郁结、通气机，正如《圣济总录·神仙导引上》所言：“人之五脏六腑，百骸九窍，皆一气之所通，气流则形和，气壅（壅）则形病”。在慢性病患者日常养护中，更是可以把调气作为病愈的枢机，通过运气以调神而愈形，促进元气的生发作用。

4.3 指导治愈疾病的生态调理

《素问·宝命全形论篇》言：“夫人生于地，悬命于天，天地合气，命之曰人。人能应四时者，天地为之父母；知万物者，谓之天子。”人之元气禀赋于天地之气而生，是自然宇宙系统分化而来的子系统。虽言天人本于一气，但天在元整体的发生秩序上比人的层级更高^[25]，因此，比人之元气更根本的是天之元气。目前尚无手段可以直接作用于天之元气，因而在调节元气的具体应用中，需要谙熟“天道”，通过调节改善天人关系链上的失序状态，从而顺应天时，以天和、地和、人和为系统性原

则，达到致中和的状态。这就要求医者“谨候气宜，无失病机”，知晓“春多感风”“夏多受暑湿”“秋多犯燥”“冬多伤寒”以及“旦慧”“昼安”“夕加”“夜甚”的一般规律。

值得一提的是，若从广义上理解“天”，除“人身”之外一切环境均归“天”属，因此，在治病时常应考虑到社会环境因素的影响，只有医者做到“诊有三常”（医生要了解患者的贵贱、贫富、苦乐之况），才能最大程度地帮助患者综合治理气行之生态，实现构建天人生态和谐的最终目标。

5 结语

气是物质-能量-信息的综合存在，在中医学认识疾病的过程中体现了气“关系实在”的思想。一元之气衍生万物是系统中医学元整体观念的鲜明体现，元整体中强调的等级秩序贯穿于万物生长的全过程，指导着临床医师通过理解气的复杂关系和其在病机中的关键地位重塑对气的认识，帮助医者树立以调气为要理形神、鼓舞元气，进行系统中医学调治的意识。同时，将思路拓展到天人关系上，提出认识疾病要随时而变，诊治疾病要内外互参，治愈疾病要达天、地、人三和。

参考文献

- [1]杨妮,齐向华.系统中医学视域下基于脉象系统认识疾病过程[J].中医杂志,2023,64(1):6-11.
- [2]祝世讷.论系统中医学[J].山东中医药大学学报,2019,43(4):324-329,323.
- [3]祝世讷.中医系统论基本原理阐释[J].山东中医药大学学报,2021,45(1):7-21.
- [4]王琦.基于中国哲学与现代科学视域的中医气本体论[J].北京中医药大学学报,2022,45(1):1-10.
- [5]纪少秀,张恒耀,刘永家.从气病论治代谢综合征探讨[J].山西中医,2014,30(3):1-3.
- [6]吴有性.温疫论[M].北京:人民卫生出版,2007:52-53.
- [7]田明清.中医学气的电实质探讨[J].中国临床康复,2003,7(23):3255.
- [8]马迎民,徐德成,范吉平.“脏腑之精化生脏腑之气”的现代医学机制[J].中医杂志,2017,58(12):996-1001,1016.
- [9]林乐昌.张载两层结构的宇宙论哲学探微[J].中国哲学史,2008,17(4):78-86.
- [10]韩金祥,韩奕.论中医气的物质基础是机体辐射电磁(量子)场[J].山东中医药大学学报,2010,34(6):474-476,479.
- [11]吴昊天,魏聪,常成成,等.评述近20年传统医学“气本质”的理论研究进展[J].中国中医基础医学杂志,

- 2016, 22(2): 281-283, 286.
- [12] 纪鑫毓. “象-气-神”三位一体中医诊疗思维模式的内涵与应用研究[D]. 北京: 中国中医科学院, 2021.
- [13] 张海生. 揭示中医学说中“气”概念的本质: 古代文献的理解及生理学的事实[J]. 光明中医, 2013, 28(12): 2470-2481.
- [14] 薛公佑, 程旺. 中医气论的本质是关系本体论[J]. 医学与哲学, 2020, 41(11): 24-26.
- [15] 祝世讷. 中医学原理探究[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2019: 228.
- [16] 陈少宗, 王振国. 系统中医研究的回顾[J]. 山东中医药大学学报, 2019, 43(4): 330-334, 323.
- [17] 祝世讷. 中医学整体观的深层内涵[J]. 山东中医学院学报, 1996, 20(4): 217-220.
- [18] 祝世讷. 论中医系统论[J]. 山东中医学院学报, 1990, 14(6): 8-13.
- [19] 孙一珂, 刘雷蕾, 朱佩, 等. 从元整体发生学观点探讨“天人相应”的本质内涵[J]. 中医学报, 2022, 37(3): 466-470.
- [20] 张永忠. 论中医学人体之气的实质是新陈代谢[J]. 中国中医基础医学杂志, 2000, 6(5): 8-11.
- [21] 任建坤, 章文春. 基于形气神三位一体生命观论《修龄要旨》导引法[J]. 江西中医药大学学报, 2016, 28(4): 19-21, 57.
- [22] 庞鹤鸣. 气本质研究: 宇宙物质结构三层面理论假说[J]. 江西中医药大学学报, 2021, 33(3): 18-22.
- [23] 苗东升. 系统科学精要[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2016: 43.
- [24] 金娜, 王济梅, 齐媛. 王有奎主任从“百病生于气”辨治肺胀[J]. 中医临床研究, 2022, 14(20): 90-93.
- [25] 马淑然. 中医系统论原理[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2021: 120.

Exploring the Connotation of *Qi* based on the Original Holistic Principle of Systematic Traditional Chinese Medicine

HU Sunlin, LIU Leilei, SUN Yike, ZHU Guangqin, SUN Xiao, HE Xue, YAN Chunxia, MA Shuran

Beijing University of Chinese Medicine, Beijing, 100029

ABSTRACT This paper systematically analyzed the understanding of *qi* from the perspectives of matter, energy, information and relationship reality, introduced the original holistic principle of systematic traditional Chinese medicine (TCM), and considered the latest research results of *qi* (three-layer material theory), trying to optimize the structure framework of the *qi* theoretical system and exhibit the occurrence and development rules of original *qi*. It emphasizes the hierarchical order of *qi* transformation following the original holistic principle, and takes this to guide the clinical understanding of “*qi* diseases”, helping doctors grasp the basic pathogenesis of the disease, that is abnormal *qi* movement, and helping them establish the awareness of providing systematic TCM treatment to patients by taking *qi* regulation as the key. At the same time, it discusses people within the structure of time and space, and points out that the treatment of diseases must comply with the principle of “the harmony of heaven, earth, and human beings”.

Keywords *qi*; systematic traditional Chinese medicine; original holism; three-level material theory

(收稿日期: 2023-04-25; 修回日期: 2023-10-20)

[编辑: 侯建春]

· 信 息 窗 ·

《中医杂志》再度入选 T1 级中医药中文科技期刊分级目录

2023 年 12 月 2 日, 由中华中医药学会主办的“第六届岐黄论坛”在北京会议中心举行。论坛以“创新引领, 助力高质量发展”为主题, 由两院院士、国医大师、科技及产业管理部门的知名专家等作学术报告, 重在介绍新观点、新进展、新方向、新模式、新方法, 以凝聚推动中医药科技创新、助力高质量发展的合力。

论坛上黄璐琦院士宣读了入选 2023—2026 年度 T1 级和 T2 级中医药中文科技期刊分级目录的期刊名单, 共有 11 本期刊入选 T1 级中医药科技期刊目录, 44 本期刊入选 T2 级中医药科技期刊目录。《中医杂志》再度入选 T1 级中医药中文科技期刊分级目录, 未来《中医杂志》将继续砥砺前行, 与时俱进, 不断提升期刊学术质量和影响力, 为助推世界一流中医药科技期刊建设贡献力量。